

LIFESKIN | ANALIZË VIZUALE E LËKURËS

Dokument paraprak për rishikim nga Dr. Violeta Gashi • 04.09.2026 • jo i validuar mjekësisht

E RËNDËSISHME: Analiza bazohet vetëm në foto dhe nuk zëvendëson ekzaminimin dermatologjik.

Përmbledhje e gjetjeve vizuale

Pamja është vizualisht më së shumti në përputhje me akne vulgaris të shkallës së moderuar, me komponent inflamator dhe komedonal. Në zonën e faqes vërehen disa papula të skuqura inflamatore, ndryshime komedonale, njolla pas-inflamatore të kuqe deri kafe dhe një parregullsi e lehtë e teksturës së lëkurës. Në disa zona mund të ketë shenja fillestare të cicatriceve atrofike të cekëta.

Shkalla: e moderuar

Parametra orientues nga fotografia

Papula inflamatore aktive	rreth 10-15 të dukshme
Pustula të mundshme	të pakta / jo të sigurta
Lezione komedonale	të pranishme në disa zona
Skuqe pas-inflamatore (PIE)	e moderuar
Pigmentim pas-inflamator (PIH)	i lehtë deri i moderuar
Teksturë / shenja atrofike	të lehta
Noduse / cista të thella	nuk dallohen qartë
Tharje / skuamëzim	minimal në foto

Vlerësim i orientueshëm i ashpërsisë

Nga një fotografi e vetme, pamja mund të korrespondojë përafërsisht me një IGA 3 (moderate). Ky klasifikim nuk është formal, sepse nuk janë parë e gjithë fytyra, zona e nofullës, gjoksi apo shpina.

Kufizimet e analizës nga foto

Nga fotografia nuk mund të vlerësohen saktë thellësia e lezioneve, dhimbja, temperatura e lëkurës, sekretimi i yndyrës, faktorët hormonalë, mikrobiologjia apo vlerat laboratorike. Ndriçimi dhe përpunimi i telefonit mund të ndryshojnë dukjen e skuqjes dhe pigmentimit.

LIFESKIN | VLERËSIM DERMATOLOGJIK

Dokument paraprak i strukturuar për përdorim orientues dhe rishikim profesional

1. Përshkrimi morfologjik

Në faqen e fotografuar vërehen leziona të shumta eritematoze, kryesisht papulare dhe sipërfaqësisht inflamatore. Janë të dukshme gjithashtu ndryshime të vogla komedonale. Në pjesën qendrore dhe të poshtme të faqes ka makula pas-inflamatore, disa më të kuqe dhe disa me ton më të errët. Sipërfaqja e lëkurës është lokalisht e parregullt, me mundësi për depresione shumë të cekëta që mund të përputhen me shenja fillestare atrofike.

2. Shpërndarja

E vlerësueshme është vetëm një faqe. Përqendrimi më i madh i ndryshimeve është në pjesën qendrore dhe laterale të faqes. Balli, hunda, ana tjetër e fytyrës, nofulla, gjoksi dhe shpina nuk janë të dukshme në këtë material.

3. Përfundim orientues

Pamja e përgjithshme është më së shumti në përputhje me akne të moderuar inflamatore-komedonale, me ndryshime pas-inflamatore dhe mundësi për shenja të hershme atrofike. Nuk shihen qartë leziona të mëdha nodulare ose cistike. Diagnoza përfundimtare duhet të bëhet pas ekzaminimit klinik.

4. Diagnoza diferenciale

Edhe pse pamja favorizon aknen, në varësi të historisë, kruarjes, dhimbjes, produkteve të përdorura dhe shpërndarjes, mund të merren në konsideratë edhe folikuliti ose reaksione irritative/inflamatore të lëkurës. Këto nuk mund të përjashtohen vetëm nga një foto.

5. Parametra për kontrollin e progresit

Parametri	Gjendja aktuale	Çfarë të krahasohet
Leziona inflamatore	rreth 10-15	ulja e numrit të lezioneve
PIE / skuqje	e moderuar	intensiteti dhe sipërfaqja
PIH / njolla të errëta	e lehtë-moderuar	zbehja graduale
Komedone / teksturë	të pranishme	më pak bllokime të poreve
Shenja atrofike	të lehta	pa depresione të reja

6. Kur rekomandohet konsultë dermatologjike më e shpejtë

Nëse shfaqen noduse të thella dhe të dhimbshme, cikatrice të reja, përkeqësim i shpejtë, ënjtje e madhe, skuqje që përhapet, temperaturë ose ndikim i fortë psikologjik, rekomandohet vlerësim mjekësor pa vonesë.

LIFESKIN | ANALIZA DHE PLANI I TERAPISË

Jo rezultate laboratorike - vetëm analiza të rekomanduara sipas rastit dhe plani 30 ml / 4 javë

1. Analiza laboratorike që mund të rekomandohen

Për aknen e zakonshme, analizat e gjakut nuk janë gjithmonë të nevojshme. Ato zgjidhen sipas simptomave, historisë hormonale dhe terapisë së planifikuar. Më poshtë janë analiza që mjeku mund t'i konsiderojë kur ka indikacion:

Analiza	Qëllimi	Kur mund të ketë kuptim
ALT / AST / GGT	Funksioni i mëlçisë	para ose gjatë disa terapive sistemike
Profil lipidik esëll	Kolesterol / trigliceride	sidomos para ose gjatë izotretinoinës
Test shtatzënie	Sipas rastit klinik	para terapive teratogjene, kur është relevante
Testosteron total / SHBG	Vlerësim hormonal	nëse ka çrregullime cikli, hirsutizëm ose dyshim për hiperandrogjenizëm
DHEA-S	Vlerësim androgenesh	nëse simptomat sugjerojnë shkak hormonal

2. Plani i terapisë LIFESKIN

TERAPIA: 30 ml

KOHËZGJATJA: 4 JAVË

Plani duhet të përshtatet sipas tolerancës së lëkurës dhe vlerësimit profesional.

3. Kontrolli pas trajtimit

- Fotografi kontrolli pas 4 javësh, në të njëjtin ndriçim, kënd dhe distancë.
- Krahasimi i numrit të lezioneve inflamatore aktive.
- Vlerësimi i skuqjes pas-inflamatore dhe njollave të pigmentuara.
- Vlerësimi i tolerancës: tharje, djegie, irritim ose përkeqësim.
- Nëse nuk ka përmirësim të mjaftueshëm ose shfaqen shenja të reja, rekomandohet rishikim dermatologjik.

4. Validimi profesional

Për rishikim dhe miratim nga profesionisti shëndetësor

Emri / nënshkrimi / data:

JO I VALIDUAR